内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·原发性醛固酮增多症

VS 继发性醛固酮增多症:肝硬化时肝功能不全,对抗利尿激素和醛固酮灭活减弱

（性感认识：高血压+低血钾在病例题先考虑原醛）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

病例题看到高血压,低血钾第一反应:原醛

一、临床表现

（1）**最早、最常见：高血压**（原醛、库欣综合征、嗜铬细胞瘤的早期表现都是高血压）

（2）**低血钾**

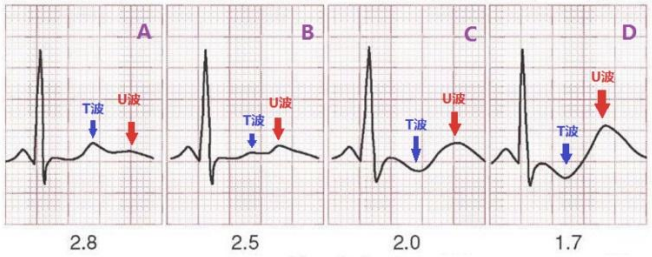
①K^+＜3.5　周期性瘫痪就是低血钾

②**肌无力**及周期性瘫痪、麻痹性肠梗阻

③T 波降低、**高 U 波**、心律失常

④代谢性**碱中毒**（血 pH、HCO_3^-、CO_2 结合力↑）　看成碳酸氢根

⑤糖耐量↓ 低钾抑制胰岛素释放,对葡萄糖耐受能力↓



小结糖耐量↓（影响胰岛素）：胖机甲 a 尿尿

糖尿病	胰岛素绝对或相对缺乏
应激	体内拮抗胰岛素的激素增多　糖皮质激素(较弱的醛固酮作用)→严重库欣综合征才会低钾
低钾	如原醛、严重库欣综合征、嗜铬细胞瘤、甲亢
肥胖	胰岛素抵抗
尿毒症	小分子毒素　中分子毒素:PTH 大分子毒素:蛋白质
应用水杨酸类药	如阿司匹林

（干扰选项：肾性糖尿——近端小管重吸收葡萄糖障碍）没有糖耐量↓

（3）其它　因为醛固酮↑→排钾作用↑,所以虽然血钾低,尿钾仍然高

高钾酸中毒,反常性的碱性尿
低钾碱中毒,反常性的酸性尿
K^+分泌↓→H^+分泌↑→血偏碱尿偏酸

①**高血钠、高尿钾、尿不呈酸性**　高血钠

②**多尿**、夜尿、正常或低比重尿（＜1.012），**口渴**（ttsx 虽然醛固酮在保水、但机体也在失水）

肾小管上皮细胞长期缺钾→变性坏死→浓缩功能↓

二、检查

①血、尿电解质

②**特征：血醛固酮↑、肾素↓、AngII↓，血醛固酮/肾素＞30**（醛固酮的亲爹是 RAAS；三全凌汤圆）

负反馈

三、治疗

（1）**特发性**醛固酮增多症

①双侧肾上腺球状带**增生**、有时伴结节

②**螺内酯（首选）、ACEI**（对血管紧张素II敏感性增强）导致醛固酮分泌↑

（2）醛固酮瘤：手术根治，术前用**螺内酯**　醛固酮受体拮抗剂

肾上腺皮质长了肿瘤,产生大量醛固酮

（3）阿米洛利、氨苯蝶啶、氨氯地平（合成醛固酮需要钙）

保钾利尿剂　CCB